جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : نعمه محمد احمد يونس
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** خمسة عشر مايو **العنوان :** الاسكان
رقم البطاقة : 27102150103681 **رقم التليفون :** 01110538509 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 11-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 15-02-1971 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي تراستوزوماب تحت الجلد و بيرتوزوماب(فيسجو) [14117] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: نعمه محمد احمد يونس
National ID: 27102150103681



تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Phesgo) Subcutaneous trastuzumab and pertuzumab)

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

بطاقة تحقيق الشخصية



نعمه

محمد احمد يونس

الاسكان العائلى - قطعة ١١١

خمسه عشر مايو - القاهره

٢٧١ ٠٢ ١٥ ٠١ ٠٣٦ ٨١

IN1789781

National ID Front
[DOCTYPEID_FRONT]

٢٧١٠٢١٥٠١٠٣٦٨١ ٢٠٢٠/٠٨

حاصله على دبلوم تجارة

انثى مسلمة متزوجة

احمد فهمى محمد حسن

١ البطاقة سارية حتى ٢٠٢٧/٠٨/٢٥



National ID - Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: نعمة محمد احمد يونس **MR. :** 6775	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالتها

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انها

POSTM RT BREAST CANCER CT4B N1 MO IDCGRADE2 REC TCHP 3 PHESGO ON 3/2/2025 RT SSM AND SLN YPT3 YPN0 EF 62 16/12 FOR C11 PHESGO AND ARIMIDEX

POSTM RT BREAST CANCER CT4B N1 MO IDCGRADE2 REC TCHP 3 PHESGO ON 3/2/2025 RT SSM AND SLN YPT3 YPN0 EF 62 16/12 FOR C12 PHESGO AND ARIMIDEX NEW ECHO PHARMACY FOR C 13, 14, 15, 16

Clinical Ph.: C13 Phesgo 600/600 mg + Aramidix + supp ttt Echo next cycle

C14 Phesgo 600/600 mg postponed due to inavailibilty + Aramidix + supp ttt echo 62% 10/3/2026

for cc15 phesgo zometa arimidex for echo next time

تحريرا في ,

التاريخ :	**19-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM 5 / 8 / 2025 G

Name	نجلاء محمد أحمد	MRN	1882/2024
		ID	ID 832/2867
Age	54	Phone	01143578666
Menopausal status	Postmenopausal	Marital status	Married
NRS SCORE		Family history	— ve
BMI		REASON OF MDT	مراجعة حالة
CO morbidity	. HTN . hystrectomy		

Clinical Data

BX:

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
7/8	7/8	+3	

Sonomammography:

Mets Workup:

R L



initial

TNM

Rt cT4b N1 Mo

. Post operative:

Rt ypT2 xpN0

Recommendations: the patient received NAC 6Tc+3HP

Rt SM +SLNB 2/2026 (ypT3 No)

MDT post op for Kadcyla

PORT

Kadcyla refused by MoH. for HP

HT

for MDT

MDT OUTCOME & PLAN

For ~~trastuzumab~~ Phesgo x1/4 cycle

. PORT — AI x5yr.

. Zometa /6month

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الاستاذه / نعمه محمد احمد برلس		
Patient No.	: 27102150103681	Request No.	: 13009180
Path No.	: 463/25	Request Date	: 03/02/2025
Sex	: Female	Verification Date	: 17/02/2025
Age	: 53 Y	Financial Category	: عجز السلام - مباشره
Referreing Doc	:	Department	: Out Patient
		Registered by	: .marwa moha

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast cancer post NACT

Nature of the specimen:
Right SM & right SLN biopsy .

Gross Examination:
- Procedure: Right simple mastectomy specimen measured 25x18x6 cm with covering skin ellipse mea
- Tumor extent : A greyish white granular tumour bed site
- Size: 7x5x3cm
- Skin involvement: Nipple & areola were unremarkable grossly
- Distance from margins: 4 cm away from deep margin
- Lymph nodes number and size: Fibrofatty tissue piece measured 5 x3 x1 cm enclosing 3SLNs up to 1 x0.5 cm ,
- Frozen section: Free SLNs (0/3)

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma (actual tumour size 7x5 cm) , (cellularity 20%)
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): Grade II (3+2+1)
- AngioInvasion: No
- Ductal carcinoma in situ: Focal (20 %)
- Skin involvement: Free nipple and areola
- Lymph node involvement: Free SLNs (0/3)
- Resection Margins: Free margins
- Histologic response to therapy: Pathologic partial response

Verified by :
Dr.Heba Hasan

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
ادارة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Ne'me[illegible]med Ahmed Yonis	Date : 11/06/2024
Exam : C.T ABDOMEN or PELVIS	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 1882/2024	Pat. ID: 54073
	Total DLP (mGy.cm): 1120

NON-CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS:

Findings:

I Chest:

- Right breast parenchymal distoriton with prominent axillary level I lymph nodes.
- Left lower lobar peripheral pulmonary nodule measuring 4 mm, likley non specific.
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No sizable hila, [illegible]tastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape with no gross abnormality of the cardiac chambers. No pericardial effusion detected.
- Normal non-enhanced CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

II Abdomen & Pelvis:

- The liver is of average size with homogenous CT texture. No focal lesions or contour irregularities, on non-contrast basis.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation, on non-contrast basis.
- Normal si[illegible] & parenchymal texture of the spleen lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density [illegible] with no stones or [illegible]-pressure changes.
- Normal non-enhanced CT appearance of the I.V.C and both suprarenals
- IUCD is noted.
- Smooth filling of the urinary bladder with diverticular outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic o[illegible]

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Cent...
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
إدارة الأشعة

Patient Name. Na'ma Mohamed Ahmed Yonis	Date : 11/06/2024
Exam : C.T ABDOMEN &PELVIS	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 1882/2024	Pat. ID: 54073
	Total DLP (mGy.cm): 1120

- No abdominal or pelvic masses or collections.
- Infra-umbilical bowel loops containig hernia.

III The scanned skeleton:

- The scanned skeleton shows no definite worrisome lytic or sclerotic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- ***Single left lower lobe pulmonary nodule likely non specific.***
- ***No definite hepatic or osseous metastatic deposits on non contrast basis.***

Dr. Amal Ibrahim.

Dr. Amr Farouk-M.D.

MOHAMED, NEAAMA Patient ID: 10110224010999 DOB: 15-Feb-1971 Date: 16-Oct-2024
Patient Lastname: Mohamed
Patient Firstname: Neaama
HIS Patient ID: 10110224010999
RIS Patient ID: 360674
Date of Birth: 15/02/1971

Procedure: 70030, Bone Scan
Medical Question:
Clinical Comment:

========== REPORT TEXT ==========
99mTc MDP Bone Scan Report (16/10/2024)

* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

" Warm cortical tracer uptake is seen at proximal right tibia; equivocal for further local radiological correlation and follow up to determine its nature.
" Otherwise, no definite evidence of active osseous deposits seen all over the rest of the surveyed skeleton.
" Degenerative changes over the dorso-lumbar vertebrae.
" Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
" Both kidneys are visualized.
Conclusion: -
" Equivocal right tibial lesion as described for further local radiological correlation and follow up to determine its nature.
" The rest of the surveyed skeleton is free from any definite active osseous lesions.

Much Obliged

Alaa Elsaeed
Mohamed Abdeltawab, MSc

========== REPORT TEXT ENDE ==========

Bone Scan
[[DOCTYPE:BONE_SCAN]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Ne'ma Mohamed Ahmed Yonis	Date : 22/05/2024
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 27102150103681	Pat. ID: 54073

DIGITAL BILATERAL SOFT TISSUE MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

Indication:

Right breast palpable mass

Report:

- ACR b: scattered fibroglandular parenchyma
- **Right breast:**
  - Obscured spiculated dense mass is seen at retro-areolar region and 12 o'clock with overlying skin thickening & pleomorphic microcalcifications reaching the nipple.
  - Corresponding by US as irregular heterogenous mass is seen at retro-areolar region at 12 o'clock measuring about 3.3x 2.2 cm & reaching the nipple.
  - Few pathologically enlarged (level 1) axillary lymph nodes are noted showing thick cortices and effaced hila, reaching 5 mm in maximum thickness.
  - Normal skin thickness.
  - No supra or infraclavicular lymph node.
- **Left breast:**
  - No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
  - Complementary ultrasound no cystic or solid mass lesions.
  - Normal skin thickness, and nipple-areola complex with average caliber of the retro-areolar central ducts.
  - Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Right breast malignant mass associated with level I pathological axillary lymphadenopathy for histopathological assessment (BIRADS 5).
- Normal sonomammography of left breast (BIRADS 1).

Dr. Ghada H. Khalifa

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Patient Name	:الأستاذ / نعمة محمد احمد يونس	Request No.	: 13009180
Patient No.	:27102150103681	Request Date	: 03/02/2025
Bath No.	:463/25	Verification Date	: 23/03/2025
Sex	: Female	Financial Category	: أورام ثدي السلام - مبادره
Age	:53 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed yousse

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data: Right breast cancer, post NACT.
Nature of Specimen: Right simple mastectomy and sentinel lymph node biopsy.

Technique:
Sections were prepared from the paraffin block, processed in Bench Mark ULTRA machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter stain. The sections treated against:
ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Results:
CONT (Positive control showed appropriate reactivity):
ER: Moderate nuclear reaction in 70% of tumor cells (score 7/8).
PR: Moderate nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 6/8).
Her2: Strong complete membrane reaction in >10% of tumor cells (score 3+).
Ki67: 20% nuclear reaction of tumor cells.

Conclusion:
Right breast cancer (post NACT), Simple mastectomy and sentinel lymph node biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II with DCIS.

ER: Positive (score 7/8).
PR: Positive (score 6/8).
Her2: Positive (score 3+).
Ki67: Positive in 20% of tumor cells.

Scoring system: "ER, PR"
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1,

Verified by :
Dr.Heba Hasan

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
نعمه
محمد احمد يونس
الاسكان الحالى - قطعة ١١١
خمسة عشر مايو - القاهرة
٢٧١٠٢١٥٠١٠٣٦٨١
IN1789781



National ID – Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]